

PLATAFORMA DE ORQUESTRAÇÃO CLÍNICA • HOSPITAIS & OPERADORAS VERTICALIZADAS

Doutor-AI: o *novo modelo operacional* da saúde.

O QUE É

Copiloto clínico + orquestração de protocolos

PARA QUEM

Hospitais e operadoras verticalizadas

EM PRODUÇÃO

22 unidades • 1.842 médicos

STATUS

Confidencial • v1

SUMÁRIO EXECUTIVO

Não é IA. É a nova forma *de operar em saúde.*

A Doutor-AI é a camada que *orquestra e garante a execução* da decisão dentro do fluxo assistencial — pronto-socorro, ambulatório, internação e enfermagem.

Para hospitais e operadoras verticalizadas, isso significa *menos variabilidade clínica, mais aderência a protocolo e eficiência operacional* mensurável.

550K⁺

atendimentos processados pela
plataforma em produção.

22

unidades ativas · 77 em
implantação · 1.842 médicos.

98%

assertividade clínica auditada em
coorte de 12 instituições.

+65%

aderência a protocolos clínicos
institucionais pós-implantação.

A TESE

Conhecimento, a saúde tem. Falta *tecnologia que executa*.

O conhecimento existe, a evidência existe e já há *múltiplos sistemas* — prontuário, protocolos, BI. O que falta é a camada que *orquestra e sustenta a execução* no fluxo: um copiloto que sugere a melhor conduta no momento certo, sob pressão de tempo e rodízio de equipe.

A OPERAÇÃO DE SAÚDE HOJE

Depende da **memória** e do **plantão** de cada profissional.

- **Variabilidade clínica** · mesma queixa, condutas diferentes
- **Protocolo no PDF** · existe, mas não chega à beira do leito
- **Documentação manual** · retrabalho, glosa e tempo perdido
- **Auditoria retrospectiva** · o erro só aparece depois
- **Sem telemetria** · gestão não enxerga a aderência real



A OPERAÇÃO *COM DOUTOR-AI*

A boa medicina vira *execução garantida* e mensurável.

- **Orquestração** · o agente certo atua em cada estágio do fluxo
- **Protocolo no contexto** · sugestão na hora da decisão
- **Documentação automática** · prontuário, codificação e alta sem retrabalho
- **Alerta & monitoramento** · red/yellow flags antes do erro
- **Aderência em tempo real** · eficiência e qualidade auditáveis

A SOLUÇÃO • ARQUITETURA DE EXECUÇÃO

A camada que *opera o fluxo* do hospital inteiro.

Tudo o que o hospital precisa para orquestrar a operação em um só lugar — uma arquitetura de execução que roda *em paralelo* ao trabalho de médicos e enfermeiros, do atendimento à governança.

01 • COPILOTO

Escuta ambient e documentos automáticos

Transcrição clínica, preenchimento automático do prontuário e dos documentos, sugestão de CID e checagem de red flags durante o atendimento.

02 • PROTOCOLOS

Central editorial de evidência

Protocolos institucionais versionados, com fonte e referência. A evidência certa, no momento certo da decisão.

03 • AUDITORIA

Aderência & pertinência em tempo real

Aderência médica × protocolo, pertinência de exames e condutas, top gaps por especialidade e drill-down por médico.

04 • GOVERNANÇA

Dashboards clínicos e financeiros

Dashboards de governança, produção, erros clínicos e impacto financeiro — visão executiva auditável.

Transcreve a consulta e *monta o prontuário* sozinho.

A escuta ambient captura a conversa e devolve um prontuário estruturado — anamnese, exame físico, hipóteses e CID — sem o médico digitar. O tempo de tela vira tempo de paciente.

— **70%** do tempo gasto em documentação clínica.

— **50%** de burnout médico — metade do burnout vem do preenchimento de documentação. Menos tela, mais olho no paciente.

30–40% de redução no tempo de consulta — menos burocracia, mais atendimentos no dia.

COMO FUNCIONA

01 Escuta ambient

Captura a consulta em áudio, sem formulário.

02 Estrutura clínica

Anamnese, exame, hipóteses e CID organizados automaticamente.

03 Revisão em 1 clique

O médico valida e assina — o registro nasce completo e auditável.

04 Alertas clínicos em tempo real

Red/yellow flags de sepse, deterioração, interações medicamentosas e contraindicações — gerados durante a consulta, não em background.

Garante a *pertinência* antes de decidir.

Antes de sugerir qualquer conduta, a plataforma **entende o contexto e traz a evidência** — garantindo a pertinência de exames, internações e condutas frente ao quadro e ao protocolo. Menos desperdício, glosa e exposição do paciente, sem travar a autonomia médica.

–51% de glosas em unidades com pertinência ativa.

COMO FUNCIONA

01 Entende o contexto

Quadro clínico, histórico, exames e protocolo aplicável.

02 Traz a evidência

Cruza solicitação com indicação clínica e diretriz.

03 Garante a pertinência

Sinaliza desvio antes do faturamento • justificativa auditável • menos retrabalho.

PROPOSTA DE VALOR • 03 DE 04

Eleva o *padrão de qualidade* de cada decisão.

Mais do que sugerir a melhor conduta, a plataforma transforma cada decisão em um **padrão auditável**: a conduta é medida contra o protocolo institucional e a gestão ganha visibilidade da aderência, das condutas clínicas e da **taxa de glosa por médico**.

+65% de aderência ao protocolo institucional.

NA INTERNAÇÃO

Doutor-AI faz um screening contínuo do paciente: red e yellow flags, interações e contraindicações, pontos de inflexão e sinais de deterioração ou melhora.

COMO FUNCIONA

01 Sugere a melhor conduta

Ranqueia a evidência para o caso; o médico decide e prescreve, sempre.

02 Mede a aderência

Cada decisão é comparada ao protocolo institucional, em tempo real.

03 Audita os profissionais

O gestor enxerga taxa de glosa, condutas clínicas e aderência por médico.

04 Dá visibilidade à gestão

Drill-down por especialidade e por médico • governança do dado e da operação.

05 Documenta com rastreabilidade

Conduta e justificativa registradas com fonte e versão — prontas para auditoria.

PROPOSTA DE VALOR • 04 DE 04

A *governança* do dado clínico e operacional em tempo real.

Cada atendimento gera dados estruturados e auditáveis — a plataforma consolida aderência, qualidade do prontuário, pertinência e impacto financeiro em tempo real, entregando visibilidade executiva completa para gestores e equipes assistenciais.

24/7 monitoramento contínuo •
98% de assertividade
auditada.

COMO FUNCIONA

01 **Telemetria em tempo real**

Aderência, qualidade do prontuário e pertinência mensuradas a cada atendimento.

02 **Dashboards executivos**

Produção, erros clínicos, glosas e ROI assistencial em painel único e exportável.

03 **Drill-down até o médico**

De rede até consulta-paciente — rastreabilidade total com framework de compliance.

04 **Auditoria por IA secundária**

Cada sugestão auditada e registrada com changelog • conformidade SBIS-CFM 2.

UMA PLATAFORMA · TODAS AS SOLUÇÕES PARA OS SEUS FLUXOS

O mesmo motor atua em *cada contexto* assistencial.

Pronto-socorro, internação, ambulatório e cirurgia — o mesmo motor de protocolos e auditoria, com visões prontas para os perfis de médico e de enfermagem.

FLUXO 01

Pronto-Socorro

Triagem → consulta → exames → reavaliação → desfecho, com pertinência e tempo de permanência sob controle.

● EM RELEASE

FLUXO 02

Internação

Admissão → evolução → coordenação de cuidado → alta, com documentação e códigos de resposta.

● EM RELEASE

FLUXO 03

Ambulatório / Telemedicina

Consulta com escuta ambient, protocolo no fluxo e aderência mensurada por especialidade.

● EM RELEASE

FLUXO 04

Cirurgia

Jornada cirúrgica — pré, intra e pós-operatório com protocolos e checklist de segurança.

○ EM DESENVOLVIMENTO

DOIS PERFIS, PRONTOS Cada fluxo tem visões dedicadas para o **perfil do médico** e o **perfil da enfermagem** — ambos em produção.

Uma segunda camada de IA *em todo o fluxo*.

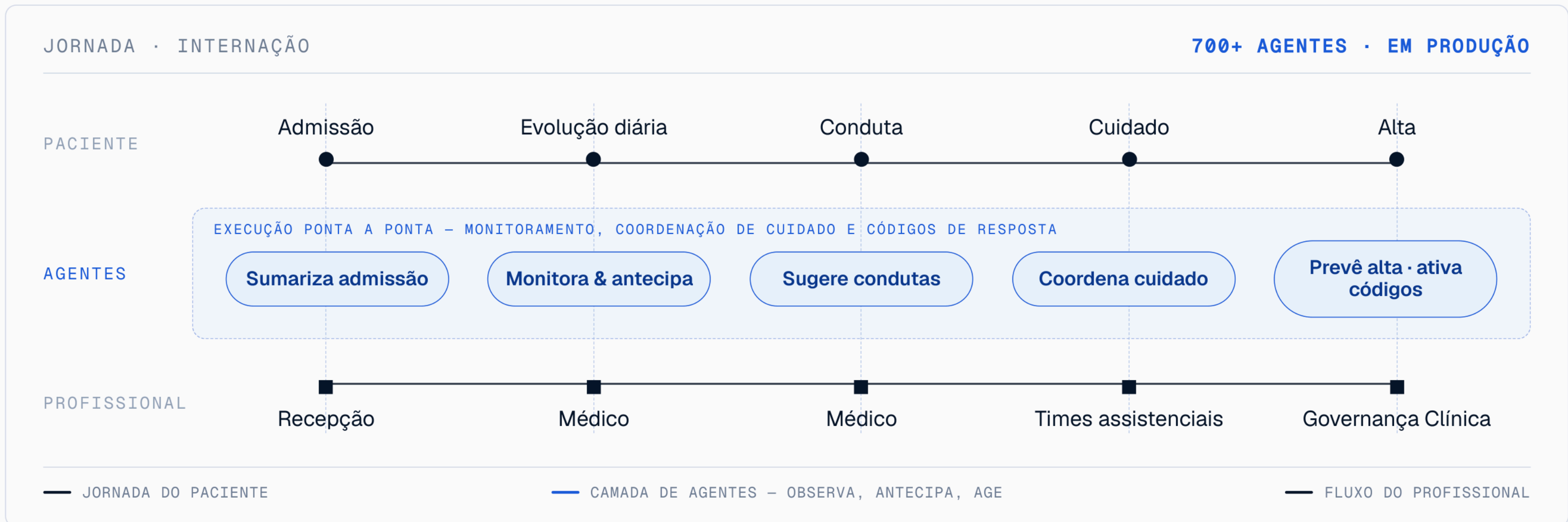
Múltiplos agentes observam, antecipam e agem em cada etapa — da chegada à governança clínica, sem tirar a decisão do médico.



FLUXO · INTERNAÇÃO

A mesma camada de IA, agora *na internação*.

Da admissão à alta, os agentes monitoram a evolução, antecipam deterioração, sugerem condutas e coordenam o cuidado multissetorial — gerando tarefas para os times e ativando códigos de resposta quando preciso.



E também no *ambulatório*, da consulta ao retorno.

O mesmo motor de protocolos e auditoria acompanha a consulta eletiva — contexto, conduta e aderência mensurados por especialidade.



CLIENTES & PARCEIROS

Construído com *instituições de referência.*

Aplicações em **hospitais, redes, operadoras e telemedicina** — em fluxos assistenciais e operacionais.

REDE HOSPITALAR

Rede D'Or São Luiz

Jornadas assistenciais e operacionais em ambiente hospitalar.

[• ESCOPO SIMILAR](#)

OPERADORA / REDE CREDENCIADA

Unimed

Do atendimento ao credenciado — auditoria e faturamento.

TELEMEDICINA

Topmed

Telemedicina e atendimento à distância em escala.

OPERADORA VERTICALIZADA

Leve Saúde

Operadora verticalizada com modelo próprio de cuidado.

+25

unidades / operadoras

Operadoras verticalizadas e redes regionais

Replicação do modelo de prontuário-com-IA em rede credenciada

VALOR POR PÚBLICO INTERNO

Uma plataforma.

Quatro públicos.

● Operações

Redução de retrabalho

Padronização do fluxo

Ganho de produtividade

● Assistência

Melhor coleta de dados clínicos

Apoio à decisão em tempo real

Alertas e protocolos institucionais

● Gestão

Mais visibilidade da operação

Indicadores da jornada

Eficiência operacional

● Financeiro

Redução de perdas

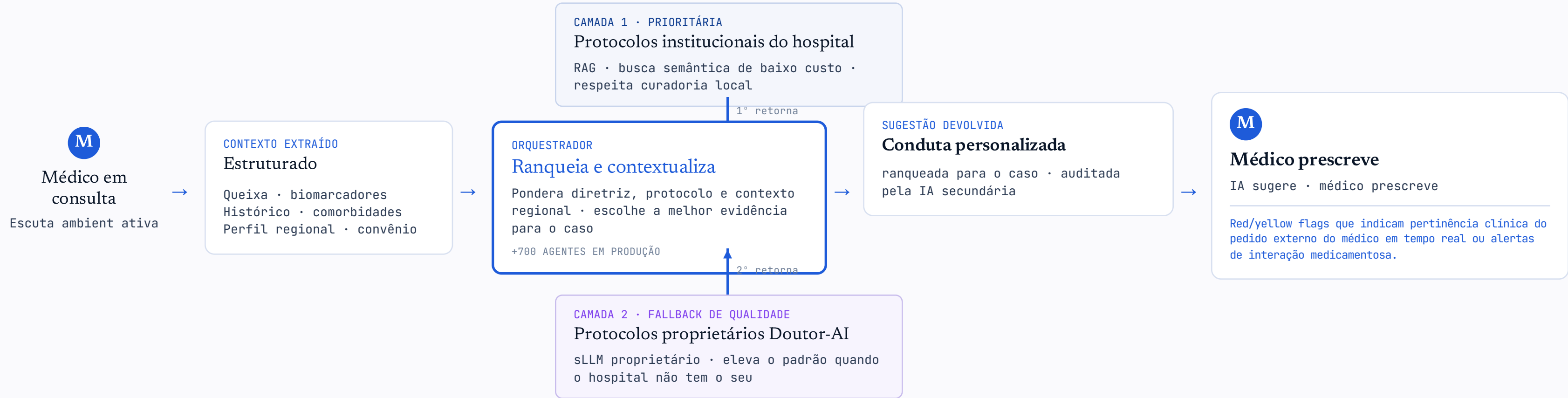
Melhor documentação clínica

Apoio a glosas e pertinência

O mesmo motor de IA gera ganhos **simultâneos** para áreas com objetivos distintos, o que facilita o caso de uso interno e a priorização da implantação.

ARQUITETURA • COMO A RECOMENDAÇÃO NASCE

A *melhor evidência* para aquele caso específico.



O copiloto que *escuta*, estrutura e documenta.

doutor-ai.com

OPERAÇÕES

Agenda

Check-in

Recepção

Consulta

Checkout

Pacientes

Navegação

Codificação

Auditoria Op.

Faturamento

Discussões

ANALYTICS

Visão Executiva

Governança Clínica

Análise Clínica

Pertinência

Erros Clínicos

Engajamento

Produção

Análise Financeira

Relatórios

Atendimento em curso

REC · 12:47

MARIA SILVA

#PT-2847

68 anos · Feminino · Cardiologia · Retorno

Resumo Clínico (IA):

Paciente com diagnóstico prévio de IC sistólica, em acompanhamento ambulatorial. FEVE atual de 42% (Eco recente). Apresenta dispneia aos médios esforços, edema (+/4+) bilateral e crepitações em bases pulmonares. Em uso de IECA, beta-bloqueador e diurético de alça. Necessária otimização da terapia.

Atendimento Atual

Histórico

Exame Físico

QUEIXA PRINCIPAL

Dispneia aos médios esforços · evolução de ~3 semanas, com piora progressiva.

DIAGNÓSTICOS · CID-10

2

I50.2 · IC sistólica

J81 · Congestão pulmonar

SINAIS VITAIS

FC

78 bpm

PA

148×92 mmHg

FR

22 rpm

SPO₂

96 %

TEMP

36,4 °C

EXAME FÍSICO

3

Edema (+/4+) bilateral

Crepitações em bases

Eupneica em repouso

Documentação preenchida automaticamente pela IA · em sincronia com o áudio da consulta

Buscar paciente, consulta, médico...

Documentação

Finalizar consulta

DR

COPILOTO CLÍNICO · TEMPO REAL

IA ativa

Conversa estruturada

ALERTAS DA IA · 2

RED FLAG · SEGURANÇA

Risco de hipercalemia

IECA + espironolactona com função renal limítrofe · checar K⁺ e creatinina antes de otimizar a terapia.

YELLOW FLAG · ATENÇÃO

PA não controlada · 148×92 mmHg

Acima da meta para IC sistólica · avaliar ajuste anti-hipertensivo antes da alta.

DR. R. ALMEIDA · DITADO CLÍNICO

Paciente trouxe Eco com FEVE de 42%. Queixando dispneia aos médios esforços. Apresentando edema (+/4+), crepitações em bases bilaterais, eupneica, SatO₂ 96%.

ACHADOS ESTRUTURADOS

Identifiquei evolução de IC com piora funcional (NYHA II → III), congestão pulmonar bilateral e edema periférico moderado. FEVE de 42% confirma **disfunção sistólica moderada**.

Como classificar a pressão arterial atual?

Normal (até 120/80)

Limítrofe (120-140 / 80-90)

Elevada (>140/90) ✓

RECOMENDAÇÃO

Sugiro **otimização do diurético de alça, ajuste do IECA** e Eco de controle em 30 dias. Protocolo IC institucional · v3.2 aplicado.

PROTOCOLO APLICADO

IC Sistólica · v3.2 · Cardiologia institucional

5 condutas sugeridas · revisão no checkout

ESCUTA AMBIENT

A consulta é capturada em áudio · IA transcreve, estrutura e gera o resumo clínico.

CONVERSA GUIADA

Chips e perguntas refinam o raciocínio clínico sem tirar o médico do fluxo.

PROTOCOLO APLICADO

Cada decisão se conecta ao protocolo institucional · pronto pro checkout.

A IA *sugere*. O médico decide.

doutor-ai.com

OPERAÇÕES

Agenda

Check-in

Recepção

Consulta

Checkout

Pacientes

Navegação

Codificação

Auditoria Op.

Faturamento

Discussões

ANALYTICS

Visão Executiva

Governança Clínica

Análise Clínica

Pertinência

Erros Clínicos

Engajamento

Produção

Análise Financeira

Relatórios

Check-Out Médico

Em encerramento

TESTE 03

56 anos ♂ Masculino TESTE 03

Paciente masculino, 48 anos, com histórico de Infarto Agudo do Miocárdio, Cardiomiopatia isquêmica, Insuficiência Cardíaca Crônica Sistólica, Insuficiência Cardíaca Congestiva e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Em [20/06/2024], apresentou piora da Insuficiência Cardíaca Crônica com fração de ejeção de 50% e hipocalemia, esta última resolvida em [25/06/2024] com suspensão da Furosemida. Em [DATA DA CONSULTA ANTERIOR], a Furosemida foi reintroduzida. Atualmente, faz uso contínuo de AAS, Atorvastatina, Carvedilol (3,125 mg, 2 vezes ao dia), Espironolactona (25 mg, 1 vez ao dia).

Contexto Clínico

Atendimento Atual

Itens do Checkout 5

EXAMES 4

LABORATORIAIS 3

Exames Laboratoriais NÃO ASSINADO

1. Hemograma Completo

2. Eletrólitos (Sódio, Potássio, Cloro)

3. Ureia e Creatinina

IMAGEM 1

Ultrassonografia Doppler do Membro Inferior NÃO ASSINADO

1. Ultrassonografia Doppler do Membro Inferior

ENCAMINHAMENTOS 1

Consulta com Cirurgião Vascular NÃO ASSINADO

Prontuário Inteligente

Discussão Clínica

Buscar paciente, consulta, médico...

Voltar à Consulta

Dados do Encerramento

DR

SUGESTÕES DA IA 5 aceitas

6 sugestões de conduta

ALERTAS IA DO CHECKOUT (2)

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA

Possível interação: Dipirona x AAS

Paciente faz uso contínuo de AAS. Dipirona pode aumentar risco de sangramento e hemorragia gástrica em uso prolongado. Considerar alternativa.

FORA DE PERTINÊNCIA

Item criado pelo médico fora de pertinência

A prescrição de Dipirona não tem evidência clínica direta no protocolo aplicado. Justifique para incluir no checkout.

EXAME Ultrassonografia Doppler do Membro Inferior + IA Aceito

EXAME Hemograma Completo + IA Aceito

EXAME Eletrólitos (Sódio, Potássio, Cloro) + IA Aceito

EXAME Ureia e Creatinina + IA Aceito

RECEITA Dipirona 500mg Médico Pendente

FORA DE PERTINÊNCIA · MÉDICO CRIOU VIA CHAT

IA não encontrou evidência no protocolo aplicado. Aguardando justificativa do médico.

ENCAMINHAMENTO Consulta com Cirurgião Vascular + IA Aceito

6 SUGESTÕES

A IA propõe condutas durante o atendimento — exames, encaminhamentos, receitas.

ALERTAS IA

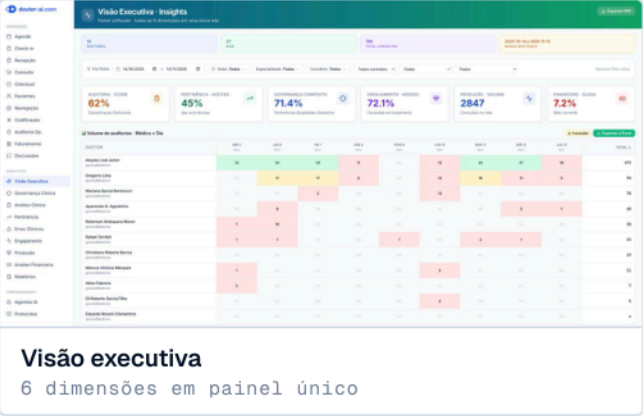
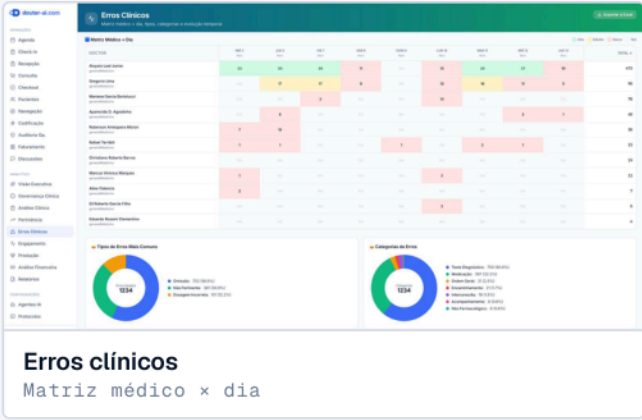
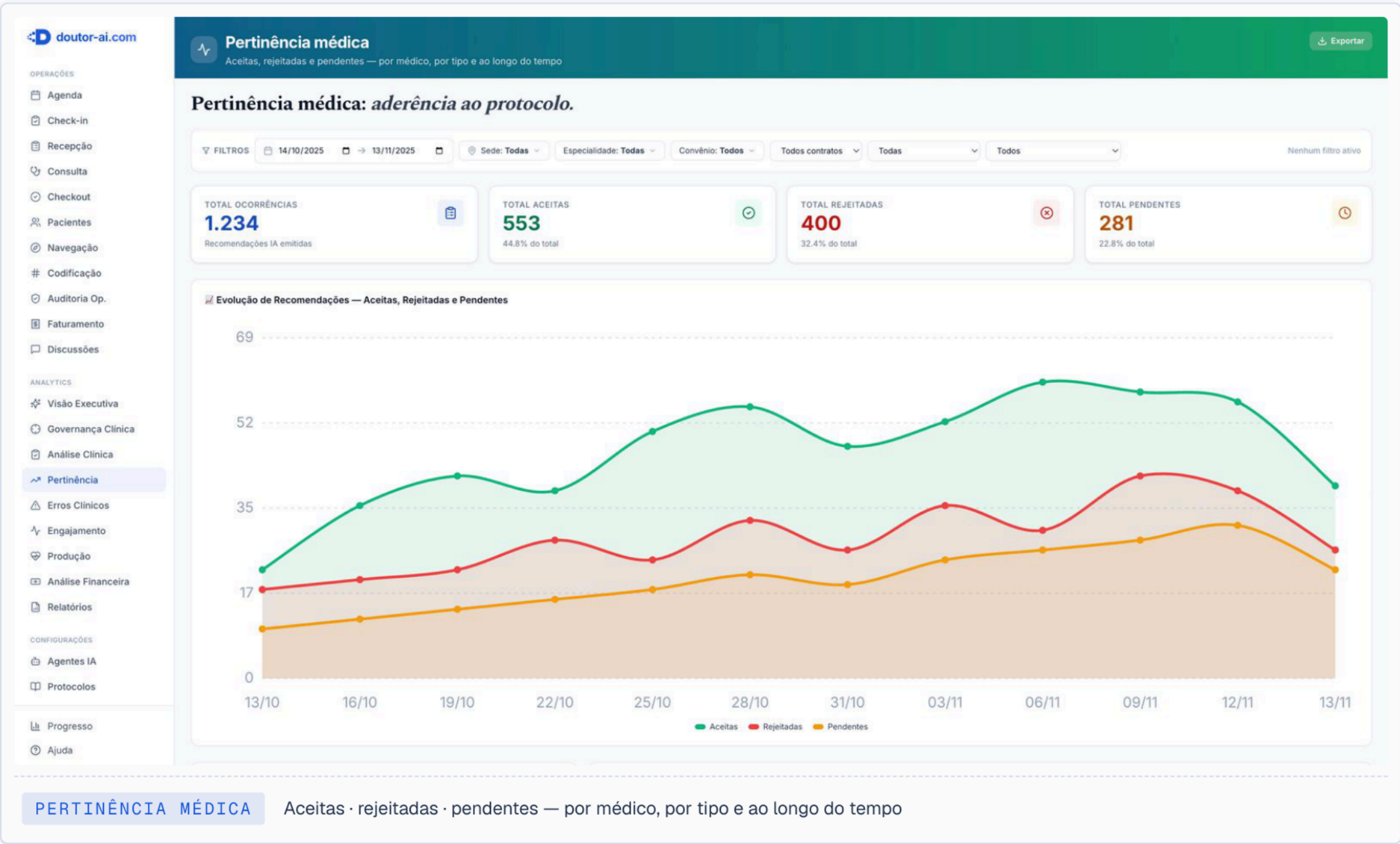
Interação medicamentosa e fora de pertinência sinalizados antes da assinatura.

DECISÃO REGISTRADA

Aceitar · pendente · rejeitar — toda escolha do médico é auditável.

PLATAFORMA • SUITE DE RELATÓRIOS EM PRODUÇÃO

A camada de *governança clínica* de toda a operação assistencial.



EM PRODUÇÃO

Mais de 10 relatórios já rodando para clientes-âncora · todos exportáveis.

VIEW NOVARTIS

Recorte dedicado por protocolo validado · dados agregados e anonimizados.

DRILL-DOWN

De agregado-rede até consulta-paciente, respeitando o framework de compliance.

Métricas de produção · ao vivo

UM NEGÓCIO EM PRODUÇÃO – RECEITA RECORRENTE REAL, NÃO PILOTO.

● AO VIVO

Todas as instituições ▾

Últimos 12 meses ▾

ATENDIMENTOS

550K+

↑ +38% QoQ

MÉDICOS ATIVOS

1.842+

↑ +41% QoQ

Especialistas em consultas reais por dia

UNIDADES ATIVAS

22

↑ +8 novas

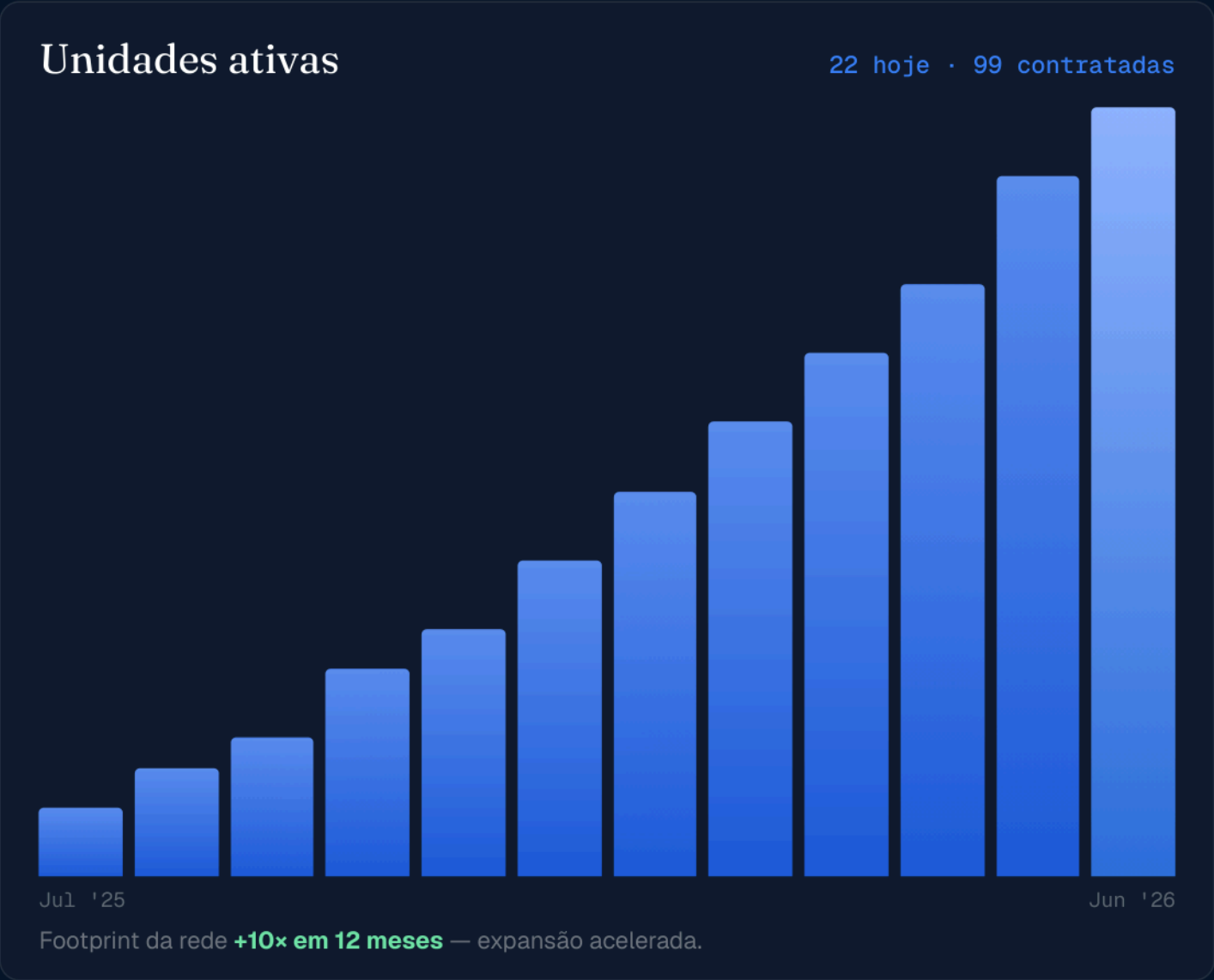
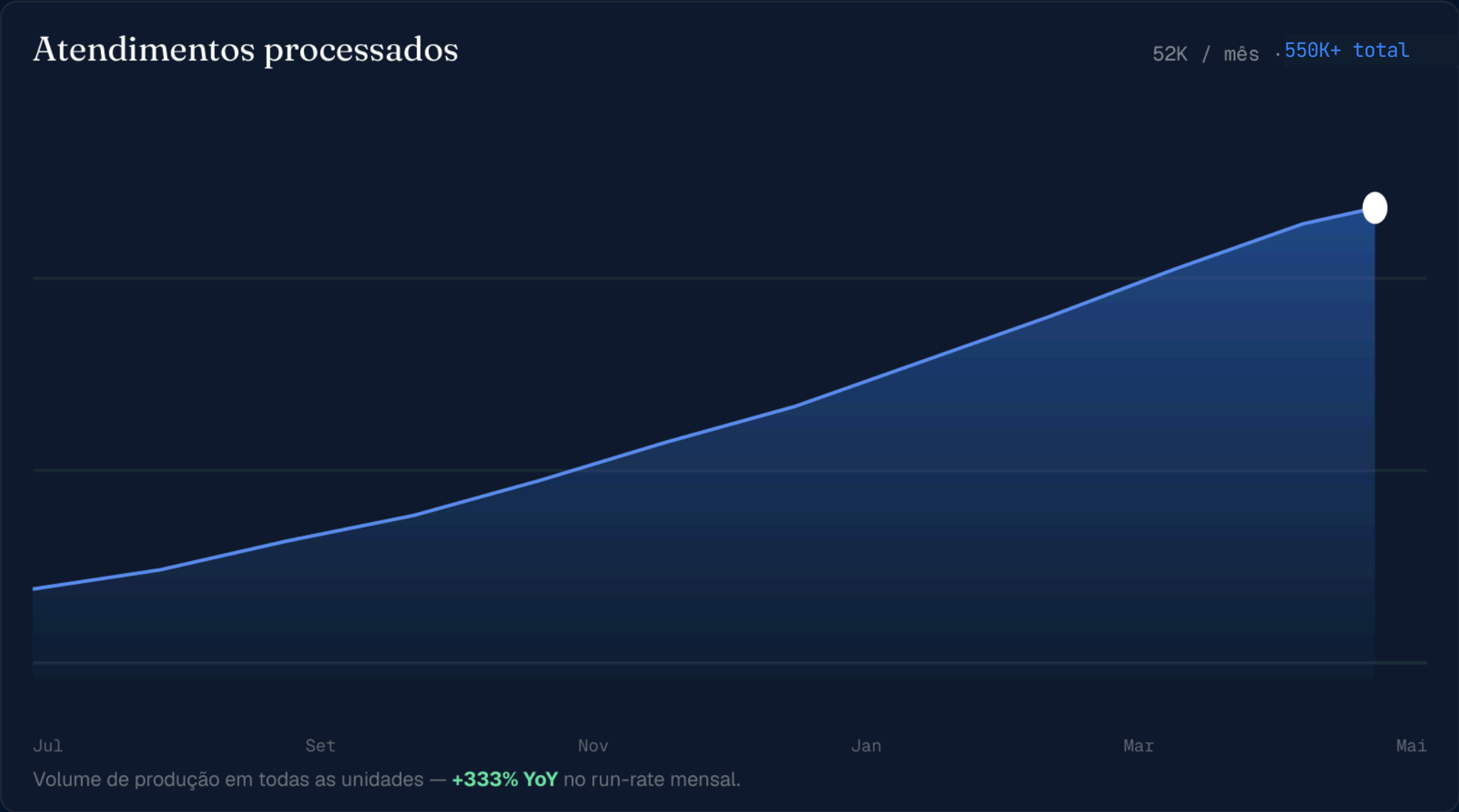
Hospitais, clínicas e telemedicina ativos

ADERÊNCIA MÉDIA

87%

↑ +12 pp

a protocolos institucionais auditados



98,7%

ACURÁCIA DA IA

em produção, fluxos clínicos reais

95%

ADOÇÃO · 30 DIAS

médicos ativos após 30 dias

81

NPS MÉDICO

satisfação classe mundial (>70)

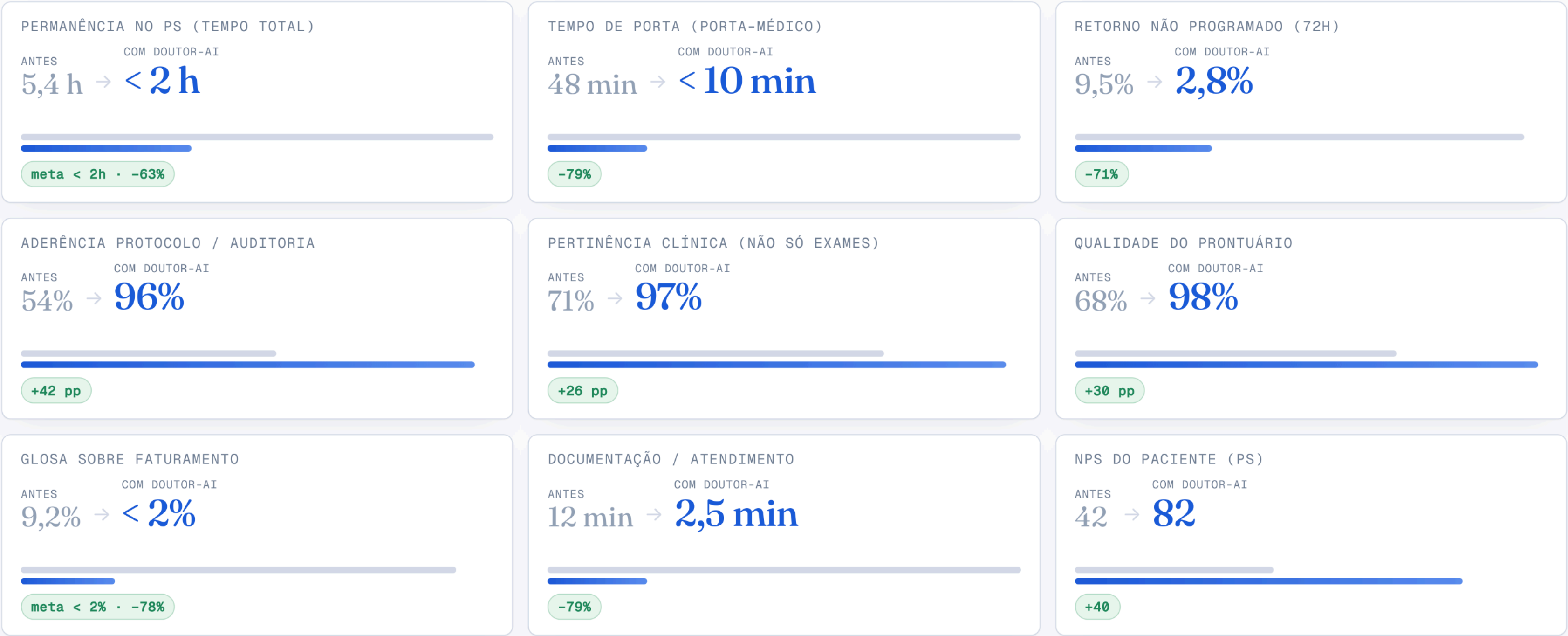
77+

EM ONBOARDING

22 ativos · 77+ contratados em rampa nos próximos 12 meses

O que muda no painel do *gestor hospitalar*.

O mesmo indicador, antes e com Doutor-AI — metas auditadas em nível de *benchmark global* de qualidade e eficiência.



MODELO DE NEGÓCIO · COMO FUNCIONA

SaaS clínico, cobrado *por atendimento*.

Primeiro o setup de implantação; depois, utilização variável — você paga pelo que usa, por atendimento. Modular: ative só o que precisa ou o pacote completo, a Medicina Inteligente.

COMO FUNCIONA

- 01

Setup & implantação

Integração ao prontuário e curadoria · personalizações a R\$ 250/hora

.
- 02

Cobrança por atendimento

Utilização variável e recorrente — você paga pelo que usa.
- 03

Modular

Transcrição, protocolos, auditoria e governança — avulsos ou no pacote completo.

ITEM	O QUE INCLUI	COBRANÇA
Transcrição & prontuário	Escuta ambient, prontuário e documentos automáticos, CID e red flags	<i>a partir de R\$ 2,00</i> / atendimento · mês
+ Protocolos	Central editorial versionada + sugestão contextual no fluxo	<i>+ R\$ 0,35</i> / atendimento · mês
+ Auditoria & pertinência	Aderência em tempo real, pertinência de condutas, drill-down	<i>+ R\$ 0,25</i> / atendimento · mês
+ Governança & analytics	Dashboards executivos, produção, erros clínicos e financeiro	<i>+ R\$ 0,10</i> / atendimento · mês
Medicina Inteligente COMPLETO	Copiloto + Protocolos + Auditoria + Governança, tudo integrado	<i>R\$ 2,70</i> / atendimento · mês
Valores de referência · tabela detalhada e desconto por volume na proposta comercial.		

Quanto a operação *economiza* por mês.

Simulação para um pronto-socorro de porte médio — os ganhos potenciais mais rápidos de mensurar, sem revelar faturamento.

OPERAÇÃO MÉDIA · PREMISSAS

Consultas de pronto-socorro 4.000 / mês

Modelo de cobrança por atendimento

CUSTO DOUTOR-AI · MEDICINA INTELIGENTE

R\$ 10,8 mil / mês

4.000 atendimentos × R\$ 2,70

GANHOS MENSAIS ESTIMADOS

Redução de glosa · 3–5 p.p. do faturamento R\$ 23–38 mil

Enfermagem de DRG & benchmarking absorvida R\$ 30.000

Redução do time de auditoria · processos mais redondos R\$ 18.000

Ganho total estimado R\$ 71–86 mil / mês

CUSTO R\$ 10,8 mil

GANHO ≈ R\$ 78 mil

GANHO LÍQUIDO

~R\$ 68 mil/mês

ROI

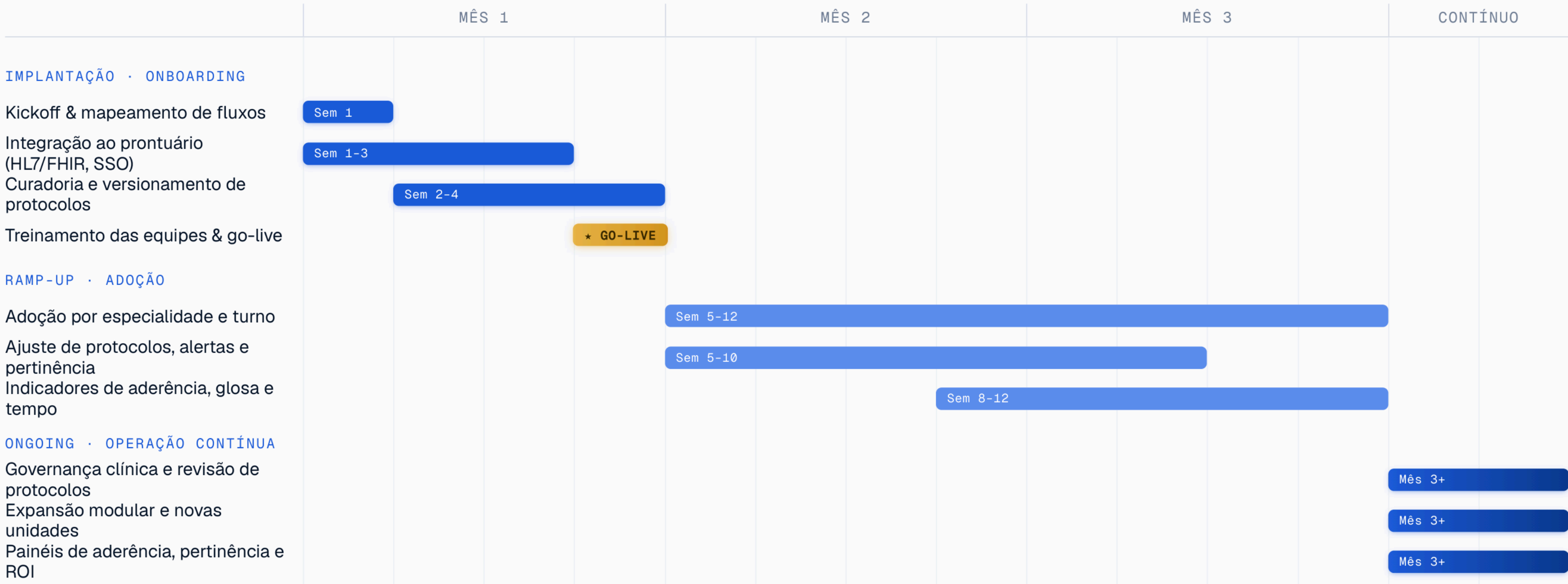
~7×

Payback imediato · valores
indicativos, ajustados na
proposta

CRONOGRAMA · IMPLANTAÇÃO, RAMP-UP E ONGOING

Três fases, do *go-live* à operação contínua.

O processo segue a jornada de implantação da Doutor-AI — do setup ao ongoing, com atividades e responsáveis acompanhados em cada frente.





Inteligência que cuida

ANDRÉ CHADE

Diretor Comercial & Time Médico

EMAIL

andre.chade@doutor-ai.com

SITE

doutor-ai.com